



Volume 2

Exames e consultas ambulatoriais

Manual do Solicitante

Sistema Estadual de Regulação- SER

PROTOCOLOS DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AMBULATORIAIS

REUNI

Central Unificada de Regulação – RJ

Versão nº3/29.12.2022



Apresentação

Este manual tem como objetivo facilitar as inserções de solicitações no Sistema Estadual de Regulação – SER.

A Política de Regulação da Atenção à Saúde deve regular de maneira mais efetiva a oferta de serviços de saúde e a demanda por estes.

A constituição de Complexos Reguladores permite, aos gestores, articular e integrar dispositivos de Regulação do Acesso como Centrais de Internação, Centrais de Consultas e Exames, Protocolos Assistenciais com outras ações de controle, avaliação e auditoria assistencial, assim como com outras funções da gestão como programação e regionalização.

A solicitação bem-feita acelera todo o processo regulatório!

O manual foi elaborado pela equipe técnica do Complexo Estadual de Regulação do Estado do Rio de Janeiro.

Kitty Crawford

Superintendente Estadual de Regulação - RJ



Carta de boas-vindas

Olá,

Você agora faz parte do grupo de Solicitantes do **Sistema Estadual de Regulação - SER**.

Sua participação é fundamental no processo regulatório, pois, é através das informações prestadas por você, que poderemos conhecer o paciente, seu estado de saúde e suas necessidades de tratamento.

O processo de regulação é um tripé baseado no solicitante (que é você), na Central de Regulação (que somos nós) e do executante (unidade para onde o paciente será encaminhado), portanto, precisamos muito da sua ajuda!

Importante saber que a Regulação trabalha com alguns critérios na hora de classificar os pacientes: gravidade, desassistência, regionalização e perfil da vaga existente. Por isso, seu paciente pode mudar sua posição de prioridade conforme os critérios elencados.

Preparamos com muito carinho a seguir um guia para facilitar o seu caminho na hora de solicitar consultas, exames ou transferência para os seus pacientes

Seja muito bem-vindo!

Equipe Multidisciplinar do Complexo Estadual de Regulação do Estado do Rio de Janeiro.



Missão do Complexo Estadual de Regulação do Estado do Rio de Janeiro

“Agilizar e qualificar o fluxo de acesso do cidadão aos serviços e ações de alta e média complexidade em saúde, de forma organizada, colocando-se a serviço da defesa do direito à saúde. ”

Resolução SES RJ nº 2102 de 14 de julho de 2003.



Índice

- 1. COMPETÊNCIAS DO SOLICITANTE**
- 2. ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE CONSULTAS / EXAMES**
- 3. SITUAÇÃO NO SISTEMA – MÓDULO AMBULATORIAL**
- 4. RECURSOS REUNI – PROTOCOLOS DE SOLICITAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES**
 - 4.1. APARELHO CARDIOVASCULAR**
 - 4.1.1. Cardiologia
 - 4.1.2. Cirurgia Cardiovascular
 - 4.1.3. Eletrofisiologia
 - 4.1.4. Cardiologia Intervencionista
 - 4.1.5. Cirurgia Vascular
 - 4.1.6. Solicitação de Exames em Cardiologia e Cardiologia Intervencionista
 - 4.2. CIRURGIA BARIÁTRICA**
 - 4.3. ONCOLOGIA**
 - 4.3.1. Cabeça e pescoço
 - 4.3.2. Tireoide
 - 4.3.3. Oftalmologia
 - 4.3.4. Neurocirurgia
 - 4.3.5. Neoplasias de Pele
 - 4.3.6. Cirurgia Geral
 - 4.3.7. Urologia
 - 4.3.8. Tórax
 - 4.3.9. Coloproctologia
 - 4.3.10. Ginecologia
 - 4.3.11. Ginecologia (Mola Hidatiforme)
 - 4.3.12. Hepatobiliar
 - 4.3.13. Mastologia
 - 4.3.14. Tecido Ósseo-Conectivo
 - 4.3.15. Hematologia
 - 4.3.16. Cardiologia
 - 4.3.17. Neurologia
 - 4.3.18. Pediatria
 - 4.3.19. Medicina Nuclear



4.4. ORTOPEDIA

- 4.4.1. Ortopedia - Joelho**
- 4.4.2. Ortopedia - Mão**
- 4.4.3. Ortopedia – Coluna**
- 4.4.4. Ortopedia – Quadril Adulto**
- 4.4.5. Ortopedia – Ombro/Cotovelo**
- 4.4.6. Ortopedia – Pediatria**
- 4.4.7. Ortopedia – Outros ambulatorios Ortopédicos**

4.5. NEUROCIRURGIA

4.6. OBSTETRÍCIA – PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO ESTRATÉGICO

4.7. MICROCIRURGIA

4.8. HEMATOLOGIA

- 4.8.1. Hematologia Adulto**
- 4.8.2. Hematologia Pediátrica**

4.9. CIRURGIA CRÂNIO-MAXILO-FACIAL

4.10. CIRURGIA PLÁSTICA

4.11. GENÉTICA MÉDICA

4.12. OUTRAS ESPECIALIDADES

4.13. TRANSPLANTE

4.14. CINTILOGRAFIA

4.15. TESTE DO SUOR – DOSAGEM DE CLORETO NO SUOR

4.16. ELASTOGRAFIA

4.17. OUTROS EXAMES

4.18. EXAMES QUE REQUEREM PREPARO PRÉVIO



1. COMPETÊNCIAS DO SOLICITANTE

1.1. Inserir o paciente no Sistema Estadual de Regulação (SER) – Módulo ambulatorial;

1.2. Inserir corretamente os dados cadastrais obrigatórios do paciente no SER:

- Número do CNS (Cartão Nacional de Saúde);
- Número de contato telefônico;
- Endereço completo;
- Data de nascimento;
- Nome completo da mãe;
- CPF;
- Dentre outros.

1.3. Conhecer os pré-requisitos de alguns recursos através das informações nos protocolos de ambulatório.

1.4. As unidades solicitantes deverão manter o cadastro do paciente atualizado periodicamente.

1.5. Acompanhar a situação do paciente no SER, verificando:

- Atualizando o quadro clínico, quando necessário;
- As pendências sinalizadas deverão ser respondidas em até 60 dias;
- Liberação de vagas;
- Agendamentos realizados.

1.6. Assim que for identificado o agendamento, o solicitante deverá **imprimir a chave de autorização e informar ao paciente/familiar a data da consulta.**



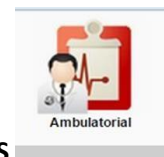
2. ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE CONSULTAS / EXAMES

- 2.1. Inserir todas as informações pertinentes ao caso do paciente, a fim de melhorar a avaliação do regulador.
- 2.2. Fornecer dados o mais completo possível na solicitação correspondente.
- 2.3. Observar a necessidade de anexar exames e solicitações médicas, conforme protocolo.
- 2.4. Nas solicitações de consulta, responder as pendências no campo “responder pendências”, em até 60 dias, pois, o sistema cancelará automaticamente após este período.
- 2.5. Assim que for identificado o agendamento, o solicitante deverá **imprimir a chave de autorização e informar ao paciente/familiar a data da consulta.**
- 2.6. Caso ocorra cancelamento, informar o motivo, **ANTES** de cancelar o pedido no SER. Os recursos ofertados são para todos e portando deverão ser utilizados com responsabilidade. Uma vez solicitado e agendado, o paciente deverá comparecer ao agendamento realizado. Caso ocorra algum impedimento ao comparecimento do paciente, deverá ser informado **com antecedência** para que outro paciente possa ocupar a vaga. Deixar uma consulta vazia, prejudica a todos os pacientes em fila!



3. SITUAÇÃO NO SISTEMA – MÓDULO AMBULATORIAL

- 3.1. **Em fila:** quando o pedido está inserido no SER, ainda aguardando a vaga.
- 3.2. **Pendência:** após analisar a solicitação, a Central identifica a necessidade de mais informações, pendenciando no sistema.
- 3.3. **Agendado:** quando a consulta do paciente foi agendada.
- 3.4. **Chegada confirmada:** quando o paciente chega na unidade.
- 3.5. **Chegada não confirmada:** quando o paciente faltou.
- 3.6. **Atendido:** quando o paciente é efetivamente atendido na unidade.
- 3.7. **Alta:** quando o paciente tem alta.
- 3.8. **Cancelado:** quando a solicitação é cancelada por algum motivo.



4. RECURSOS REUNI – PROTOCOLOS DE SOLICITAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES

- Deverão ser feitas no SER (Sistema Estadual de Regulação) >>> Módulo Ambulatorial >>> Prancheta.
- Inserir os dados sociais do paciente (nome, idade, número de CNS, nome completo, CPF, sexo, data de nascimento, nome da mãe, endereço completo e **telefone de contato do paciente**).
- Identificar o médico solicitante, devidamente cadastrado no SER.
- Informar a hipótese diagnóstica (classificação de risco e CID 10), a natureza da solicitação (mandado judicial – sim ou não), a unidade de origem e anexos (caso necessário).
- **Observação: A Central regula apenas o acesso dos pacientes à unidade de saúde. Uma vez atendido, a programação cirúrgica e a técnica a ser utilizada é de inteira responsabilidade da unidade executante. Não temos como interferir na fila interna das unidades bem como no tempo de espera para a realização do procedimento.**

4.1. APARELHO CARDIOVASCULAR

Solicitação de Consulta de primeira vez em Cardiologia (Alta Complexidade), Cirurgia Cardiovascular, Eletrofisiologia, Cardiologia Intervencionista e Cirurgia Vascular.

4.1.1. CARDIOLOGIA - ALTA COMPLEXIDADE (ambulatório 1ª vez)

Recurso	Requisitos necessários
CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA	• Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clara e detalhada do caso. • Inserir exame de Ecocardiograma recente.
AValiação de CARDIOPATIA CONGÊNITA PEDIÁTRICA (INTERNADOS)	• Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clara e detalhada do caso. • Inserir exame de Ecocardiograma recente. • Destina-se a pacientes menores de 18 anos.
CARDIOPATIA CONGÊNITA (ADULTOS)	• Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clara e detalhada do caso (cardiopatias abordadas previamente necessitam da descrição das cirurgias e procedimentos realizados com as respectivas datas). • Inserir exame de Ecocardiograma recente (< 6m). • Destina-se a pacientes com 18 anos ou mais com sintomas ou sequela da cardiopatia.



4.1.2. CIRURGIA CARDIOVASCULAR (ambatório 1ª vez)

Recurso	Requisitos necessários
ANEURISMA/ DISSECÇÃO DE AORTA TORÁCICA	• Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clara e detalhada do caso. • Inserir exame de Ecocardiograma recente. • Inserir exames de imagem com laudos que comprovem a doença (Tomografia ou Angiotomografia ou Angioressonância).
IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADO R(CDI)	• Indicações: Diagnóstico de Taquicardia Ventricular sustentada ou morte súbita abortada ou disfunção ventricular grave com episódios de taquicardia ventricular não sustentada, comprovados ao Holter. • Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clara e detalhada do caso. • Inserir ECG e Ecocardiograma (<6m). • Inserir Holter 24 horas ou teste ergométrico.
CIRURGIA OROVALVAR	• Indicações: Doença orovalvar moderada ou grave comprovada por Ecocardiograma. • Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clara e detalhada do caso. • Inserir ECG e Ecocardiograma (<6m).
CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO	• Indicações: Portadores de Doença Arterial Coronariana (DAC) comprovada por cateterismo cardíaco (lesão do tronco de coronária esquerda, lesão trivascular). • Inserir Cateterismo Cardíaco realizado há menos de 1 ano. • Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clara e detalhada do caso. • Inserir ECG e Ecocardiograma.
IMPLANTE DE MARCAPASSO	• Indicações: Bradiarritmias ou Bloqueios Atrioventriculares. • Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clara e detalhada do caso. • Inserir ECG e Ecocardiograma (<6m). • Inserir Holter 24 horas ou teste ergométrico.

4.1.3. ELETROFISIOLOGIA/ABLAÇÃO (ambatório 1ª vez)

Recurso	Requisitos necessários
ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO (ABLAÇÃO)	• Indicações: Arritmias complexas com indicação de avaliação de ablação por radiofrequência. • Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clara e detalhada do caso. • Inserir ECG e Ecocardiograma (<6m). • Inserir Holter 24 horas ou teste ergométrico.



4.1.4. CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (ambulatório 1ª vez)

Recurso	Requisitos necessários
PRÉ-ANGIOPLASTIA	• Indicações: Portadores de DAC com lesões moderadas a graves, comprovadas por cateterismo cardíaco. • Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clara e detalhada do caso. • Inserir Cateterismo Cardíaco realizado há menos de 1 ano.

4.1.5. CIRURGIA VASCULAR (ambulatório 1ª vez)

Recurso	Requisitos necessários
Vasculopatia Arterial Periférica	• Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clara e detalhada do caso, com exame físico direcionado (amplitude dos pulsos arteriais, temperatura dos membros, presença de claudicação, etc.). • Inserir exame de imagem (Doppler ou Angiorressonância ou Angio-TC de membros ou Arteriografia).
Vasculopatia Carotídea	• Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clara e detalhada do caso. • Inserir exame de Doppler de artérias carotídeas (< 4 meses) ou Angio-TC.
ANEURISMA/ DISSECÇÃO DE AORTA ABDOMINAL	• Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clara e detalhada. • Inserir exame de Angio-TC ou Tomografia. Obs.: Dissecção acima da saída das Artérias Renais deverá ser encaminhada à Cirurgia Cardiovascular (Aneurisma/ Dissecção de Aorta Torácica).
FÍSTULA ARTERIOVENOSA PARA HEMODIÁLISE	• Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clara e detalhada do caso.

4.1.6. SOLICITAÇÃO DE EXAMES EM CARDIOLOGIA

4.1.6.1. CARDIOLOGIA

Recurso	Requisitos necessários
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO (INTERNADOS)	• Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clara e detalhada do caso e justificativa para a realização deste exame. • Informar modo ventilatório. • Inserir exame de Ecocardiograma Transtorácico.
ECOCARDIOGRAMA DE ESTRESSE	• Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clara e detalhada do caso e justificativa para a realização deste exame. • Inserir exame de Ecocardiograma Transtorácico.



4.1.6.2. CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA

Recurso	Requisitos necessários
CATETERISMO CARDÍACO (AMBULATORIAL)	• Destina-se a pacientes em domicílio. • Inserir no SER a solicitação médica em formulário de Alto Custo. • Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clara e detalhada do caso (História clínica, tratamentos prévios efetuados, uso de medicações regulares, história de alergia a iodo). • Inserir exame de ECG e/ou Ecocardiograma ou Teste ergométrico ou Cintilografia Miocárdica. • Inserir resultado de Hematócrito, hemoglobina, ureia, creatinina e glicose (< 3 m).
CATETERISMO CARDÍACO (INTERNADOS)	• Destina-se a pacientes em ambiente hospitalar. Informar o tipo de leito atual (CTI ou enfermaria). • Inserir no SER a solicitação médica em formulário de Alto Custo. • Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clara e detalhada do caso (História clínica, informar modo ventilatório, tratamentos prévios efetuados, uso de medicações regulares, história de alergia a iodo). • Inserir resultado de Hematócrito, hemoglobina, ureia, creatinina e glicose. • Inserir se o paciente foi trombolisado ou não, tempo de início de sintomas do infarto, curva enzimática de CK, CKMB e TROPONINA. • Inserir exame de ECG e/ou Ecocardiograma. • Caso o paciente apresente alterações sugestivas de Insuficiência Renal (U>80 ou Cr>2,0 é necessária avaliação do nefrologista). • HT<27 e Hb<9,0 não poderão realizar o exame.
ARTERIOGRAFIA PERIFÉRICA (AMBULATORIAL)	• Destina-se a pacientes em domicílio. • Inserir no SER a solicitação médica em formulário de Alto Custo. • Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clara e detalhada do caso (História clínica, tratamentos prévios efetuados, uso de medicações regulares, história de alergia a iodo). • Inserir resultado de Hematócrito, hemoglobina, ureia e creatinina. • Inserir exame de Doppler (exceto para arteriografia cerebral).
ARTERIOGRAFIA CEREBRAL (AMBULATORIAL)	• Inserir no SER a solicitação médica em formulário de Alto Custo. • Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clara e detalhada do caso (História clínica, tratamentos prévios efetuados, uso de medicações regulares, história de alergia a iodo). • Inserir Exame de imagem (TC ou RNM de crânio).
ARTERIOGRAFIA PERIFÉRICA (INTERNADOS)	• Destina-se a pacientes em ambiente hospitalar. • Inserir no SER a solicitação médica em formulário de Alto Custo. • Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clara e detalhada do caso (História clínica, informar modo ventilatório, tratamentos prévios efetuados, uso de medicações regulares, história de alergia a iodo). • Inserir resultado de Hematócrito, hemoglobina, ureia e creatinina. • Inserir Exame de Doppler do Membro afetado.



4.2. CIRURGIA BARIÁTRICA

4.2.1. Solicitação de consulta de primeira vez em Cirurgia Bariátrica

Recurso	Requisitos necessários
CIRURGIA BARIÁTRICA	Conforme preconiza a Portaria SAS nº 492 de 31/08/2007, abaixo: Critérios de inclusão: - IMC $\geq$ 40 kg/m², sem comorbidades, que não respondem ao tratamento conservador (dieta, psicoterapia, atividade física, etc.), realizado durante pelo menos dois anos e sob orientação de equipe credenciada / habilitada como Unidade de Assistência de Alta Complexidade ao paciente portador de obesidade. - IMC $\geq$ 40 kg/m² com comorbidades que ameaçam a vida. - IMC entre 35 e 39,9 kg/m² portadores de doenças crônicas desencadeadas ou agravadas pela obesidade. Devem possuir laudo do endocrinologista informando que não há obesidade por doenças endócrinas ou que essa esteja em tratamento estabilizada. - Idade entre 18 anos e 65 anos, com alguma das indicações acima. Se entre 16 e 18 anos, deverão apresentar comprovação de consolidação das epífises dos ossos longos. Critérios de exclusão: - Obesidade decorrente de doença endócrina (p. ex., Síndrome de Cushing devido à hiperplasia suprarrenal). - Incapacidade intelectual para compreender todos os aspectos do tratamento. - Ausência de suporte familiar constante. - Alcoolismo; dependência química e outras drogas, distúrbio psicótico grave (bulimia, inclusive) ou história recente de tentativa de suicídio. Anexar (ou descrever de forma clara e detalhada): - Encaminhamento médico descrevendo o quadro clínico e indicando o procedimento. - Hemograma com plaquetas; Coagulograma; Ureia e Creatinina; Glicemia de jejum; Hemoglobina glicosilada (HbA1C); Ácido úrico; T3, T4, TSH; Colesterol total, HDL e Triglicerídeos.



4.3. ONCOLOGIA

4.3.1. Consulta de primeira vez em Oncologia - CABEÇA E PESCOÇO

- Destina-se aos pacientes com **DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE NEOPLASIA**, com sítio primário em cabeça e pescoço.

Local da lesão	Requisitos necessários
CABEÇA E PESCOÇO	• Fossa Nasal e Seios Paranasais – Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clínica do caso e resultados dos exames pertinentes (anatomopatológico e exame de imagem - TC e/ou RNM de Crânio e face). • Glândulas salivares - Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clínica do caso e resultados dos exames pertinentes (anatomopatológico e exame de imagem – USG ou TC com contraste das glândulas salivares). • Massa cervical - Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clínica do caso e resultados do exame anatomopatológico e exame de imagem -TC de pescoço e tórax e face, evidenciando sítio primário em região de via aérea superior (rinofaringe, traqueia, laringe). • Lábio - Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clínica do caso e resultados do exame anatomopatológico, confirmando o sítio primário. • Órbita - Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clínica do caso e resultados dos exames pertinentes (anatomopatológico ou exame de imagem - TC e/ou RNM Crânio e face). • Pele - Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clínica do caso e resultados do exame anatomopatológico, confirmando o sítio primário. • Orelha - Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clínica do caso e resultados do exame anatomopatológico, confirmando o sítio primário. • Cavidade oral - Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clínica do caso e resultados do exame anatomopatológico, confirmando o sítio primário. • Faringe / laringe - Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clínica do caso e resultados dos exames pertinentes, com indicativo do sítio primário em rinofaringe, traqueia, laringe (anatomopatológico e/ou exame de imagem - TC de pescoço e tórax e face ou laringoscopia).



4.3.2. Consulta de primeira vez em Oncologia – TIREOIDE

Local da lesão	Requisitos necessários
TIREOIDE	Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clínica do caso e resultados do exame anatomopatológico ou citopatológico (PAAF), confirmando o sítio primário.

4.3.3. Consulta de primeira vez em Oncologia – OFTALMOLOGIA

Local da lesão	Requisitos necessários
OFTALMOLOGIA	- Destina-se aos pacientes com lesão suspeita em conjuntiva, córnea, íris, retina e/ou coroide. - Inserir no SER o encaminhamento médico indicando a forte suspeita clínica.

4.3.4. Consulta de primeira vez em Oncologia – NEUROCIRURGIA

- Pacientes com suspeita de metástase em SNC deverão ser inseridos de acordo com o sítio primário.

Local da lesão	Requisitos necessários
CÉREBRO/HIPÓFISE/SELA TÚRCICA	Inserir no SER o encaminhamento médico indicando presença de Nódulo ou Massa em Sistema Nervoso Central (SNC) diagnosticado por Tomografia Computadorizada e/ou Ressonância Magnética de Crânio, sugestivo de sítio primário.

4.3.5. Consulta de primeira vez em Oncologia – NEOPLASIAS DE PELE

Local da lesão	Requisitos necessários
PELE	Inserir no SER o encaminhamento médico indicando a forte suspeita clínica e resultado do exame histopatológico, confirmando o sítio primário.



4.3.6. Consulta de primeira vez em Oncologia – CIRURGIA GERAL

Local da lesão	Requisitos necessários
ESÔFAGO	- Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clínica do caso. - Inserir o resultado do exame de Endoscopia Digestiva Alta (EDA) e/ou Tomografia Computadorizada de Abdome e Tórax com lesão suspeita e laudo histopatológico.
ESTÔMAGO/DUODENO	- Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clínica do caso. - Inserir o resultado do exame de Endoscopia Digestiva Alta (EDA) e/ou Tomografia Computadorizada de Abdome e Tórax com lesão suspeita e laudo histopatológico.

4.3.7. Consulta de primeira vez em Oncologia – UROLOGIA

Local da lesão	Requisitos necessários
RIM	Inserir no SER o encaminhamento médico indicando forte suspeita clínica e resultados de exames de imagem com lesão sólida suspeita e Tomografia Computadorizada de Abdome. Laudo histopatológico se houver.
BEXIGA	Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clínica do caso e resultado de exame de Cistosopia com biópsia positiva e/ou massa vesical ou Tomografia Computadorizada de Abdome e Pelve ou USG.
TESTÍCULO	Inserir no SER o encaminhamento médico com descrição de massa testicular ao exame clínico com suspeita de neoplasia. Inserir USG de bolsa escrotal e/ou TC abdome e/ou pelve mostrando massa testicular com suspeita de neoplasia. Laudo histopatológico, se houver.
PRÓSTATA	Inserir no SER o encaminhamento com a descrição clínica do caso e resultados dos exames de toque retal alterado e PSA > 4 ng/ml, com diagnóstico confirmado por biópsia.
PÊNIS	Inserir no SER o encaminhamento médico com descrição de lesão peniana ao exame clínico com suspeita de neoplasia. Laudo histopatológico, se houver.

4.3.8. Consulta de primeira vez em Oncologia – TÓRAX

- Pacientes com suspeita de metástase pulmonar deverão ser inseridos de acordo com o sítio primário.**

Local da lesão	Requisitos necessários
NÓDULOS TUMORAIS DO PULMÃO	- Inserir no SER o encaminhamento médico para o Serviço de Cirurgia Torácica, com indicação médica de forte suspeita clínica, informando o sítio primário. Laudo histopatológico se houver. - Todos os pacientes encaminhados deverão ter um exame Tomografia Computadorizada do tórax e abdome superior.
TUMORES MEDIASTINO	
TUMORES DA PLEURA	



4.3.9. Consulta de primeira vez em Oncologia – COLOPROCTOLOGIA

Local da lesão	Requisitos necessários
CÓLON	• Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clínica do caso. • Inserir o resultado do exame de Colonoscopia e/ou Tomografia Computadorizada de Abdome Total e Pelve com contraste e/ou RNM de Pelve. • Inserir laudo histopatológico
RETO	• Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clínica do caso. • Inserir o resultado do exame de Colonoscopia (ou Retossigmoidoscopia) e/ou Tomografia Computadorizada de Abdome Total e Pelve com contraste e/ou RNM de pelve. • Inserir laudo histopatológico

4.3.10. Consulta de primeira vez em Oncologia – GINECOLOGIA

Local da lesão	Requisitos necessários
VULVA	• Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clínica do caso e o Laudo Histopatológico.
VAGINA	• Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clínica do caso e o Laudo Histopatológico.
COLO UTERINO E ENDOMÉTRIO	• Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clínica do caso e o Laudo Histopatológico.
TUMOR DE OVÁRIO	• Inserir no SER o encaminhamento médico indicando forte suspeita clínica e o exame de Imagem RNM, TC e/ou USG e Marcadores Tumorais (se possível).
TROMPAS E ANEXOS	• Inserir no SER o encaminhamento médico indicando forte suspeita clínica e o exame de Imagem RNM, TC e/ou USG e Marcadores Tumorais (se possível).

4.3.11. Consulta de primeira vez em Oncologia – GINECOLOGIA

• Doença Trofoblástica Gestacional (Mola Hidatiforme)

Lesão	Requisitos necessários
Doença Trofoblástica Gestacional (Mola Hidatiforme)	• Inserir no SER o encaminhamento médico com descrição detalhada do caso e resultado de BHCG plasmático, exame de USG pélvica ou transvaginal e /ou histopatológico indicando o diagnóstico.



4.3.12. Consulta de primeira vez em Oncologia – CIRURGIA HEPATOBILIAR

- Pacientes com suspeita de metástase hepática deverão ser inseridos de acordo com o sítio primário.

Local da lesão	Requisitos necessários
FÍGADO E VIAS BILIARES	• Inserir no SER o encaminhamento médico indicando forte suspeita clínica de tumor primário e resultado de exame de TC abdome / RNM abdome / Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE) e Marcadores Tumorais (se possível).
PÂNCREAS	• Inserir no SER o encaminhamento médico indicando forte suspeita clínica e resultado do exame de Tomografia Computadorizada de abdome com massa sólida ou mista ou cística.

4.3.13. Consulta de primeira vez em Oncologia – MASTOLOGIA

Local/tipo da lesão	Requisitos necessários
MAMA COM LESÃO PALPÁVEL	• Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clínica do caso e anexar o laudo Histopatológico. • Informar estágio clínico da doença.
MAMA COM LESÃO IMPALPÁVEL	• Inserir no SER o encaminhamento médico indicando forte suspeita clínica e anexar os exames de USG e Mamografia com categoria 4 e 5 de BI - RADS.

4.3.14. Consulta de primeira vez em Oncologia – Tumor de Tecido Ósseo-Conectivo (TOC) ADULTO / INFANTIL

- Pacientes com suspeita de metástase óssea deverão ser inseridos de acordo com o sítio primário.

Local da lesão	Requisitos necessários
CÂNCER ÓSSEO	• Inserir no SER o encaminhamento médico indicando forte suspeita clínica e anexar o laudo histopatológico e/ou exame de imagem.
SARCOMA DE PERNAS E BRAÇOS	• Inserir no SER o encaminhamento médico indicando forte suspeita clínica e anexar o laudo histopatológico e/ou exame de imagem.
TUMORES MALIGNOS DE PARTES DE MOLES	• Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clínica do caso e anexar o laudo histopatológico e/ou exame de imagem.
MELANOMA >2 CM	• Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clínica do caso e anexar o laudo histopatológico.



4.3.15. Consulta de primeira vez em Oncologia – HEMATOLOGIA

- **Oncologia – HEMATOLOGIA ADULTO**

Recurso	Requisitos necessários
ONCOLOGIA HEMATOLOGIA ADULTO	Crítérios de Exclusão: a. Adenomegalias reacionais a viroses agudas. b. Atipias linfocitárias em presença de viroses agudas. c. Trombocitose em hemograma único. d. Pacientes com adenomegalias suspeitas sem biópsia. Crítérios de Inclusão/ Agendamento: a. Dor óssea, com eletroforese de proteínas séricas, evidenciando Gamopatia Monoclonal (casos de Mieloma múltiplo). b. Bicitopenia após afastar todas as causas clínicas (hipotireoidismo, doenças hepáticas, uso de medicamentos, esplenomegalia com doença hepática). c. Citopenias + manifestações clínicas suspeitas de leucemia aguda (fadiga generalizada, fraqueza, palidez, equimose, petéquias, sangramentos, infecções recorrentes) – VIDE OBSERVAÇÃO. - c.1. Citopenias + linfonodomegalia e esplenomegalia não explicada por quadro infeccioso agudo; ou - c.2. Presença de blastos/ promielócitos no sangue periférico; ou - c.3. Paciente com febre + neurogenia ($< 1500 /\mu\text{L}$); ou - c.4. Bicitopenia/pancitopenia com alterações hematológicas graves: • Hemoglobina $< 7 \text{ g/dL}$; e/ou • Neutrófilos $< 500 \text{ cels}/\mu\text{L}$; e/ou • Plaquetas $< 50 \text{ mil cels}/\text{mm}^3$. d. Trombocitose: - d.1. Isolada $> 600.000/\text{mm}^3$ em 3 exames c/ intervalo $< 1\text{m}$; ou - d.2. Acompanhada de leucocitose e aumento do hematócrito; ou - d.3. Associada a sintomas vasomotores, sangramento ou trombose (após avaliação em serviço de urgência / emergência); ou - d.4. Associada a leucocitose ou policitemia. Excluir: trombocitose persistente após exclusão de causas secundárias (quadro infeccioso atual, anemia ferropriva, esplenectomia /asplenia, trauma/cirurgia recente).



**ONCOLOGIA
HEMATOLOGIA
ADULTO**

e. Trombocitose:

- e.1. Isolada $> 600.000/\text{mm}^3$ em 3 exames c/ intervalo $< 1\text{m}$; ou
- e.2. Acompanhada de leucocitose e aumento do hematócrito; ou
- e.3. Associada a sintomas vasomotores, sangramento ou trombose (após avaliação em serviço de urgência / emergência); ou
- e.4. Associada a leucocitose ou policitemia.

Excluir: trombocitose persistente após exclusão de causas secundárias (quadro infeccioso atual, anemia ferropriva, esplenectomia /asplenia, trauma/cirurgia recente).

f. Leucocitose com desvio à esquerda em ausência de infecção:

- f.1. Leucocitose + manifestações clínicas suspeitas de leucemia aguda (fadiga generalizada, fraqueza, palidez, equimose, petéquias, sangramentos, infecções recorrentes); ou
- f.2. Presença de blastos e promielócitos no sangue periférico; ou
- f.3. Leucostase (presença de sintomas respiratórios, neurológicos, priapismo em pessoas com hiperleucocitose) ou leucócitos > 100 mil cels. $/\text{mm}^3$.

g. Policitemia:

- g.1. Suspeita de Policitemia vera ($\text{hb} > 16,0\text{g/dl}$ em mulheres e $> 16,5\text{g/dl}$ em homens), em pessoas com sintomas sugestivos: prurido após o banho, gota, trombose venosa ou arterial prévia, sangramento, esplenomegalia; ou
- g.2. Policitemia persistente ($\text{hb} > 16,0\text{g/dl}$ em mulheres e $> 16,5\text{g/dl}$ em homens) após repetição do hemograma em 1 mês e exclusão de causas secundárias (DPOC, tabagismo, hepatocarcinoma, carcinoma renal).

OBSERVAÇÃO: PACIENTES COM SUSPEITA DE LEUCEMIA AGUDA NÃO SÃO REGULADOS AMBULATORIALMENTE. NECESSÁRIO ESTAR INTERNADO E INSERIDO NO SISTEMA SER PARA TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR.



• **Oncologia – HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA**

ONCOLOGIA HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA	Crítérios de Exclusão: a. Adenomegalias reacionais a viroses agudas. b. Atipias linfocitárias em presença de viroses agudas. c. Trombocitose em hemograma único. d. Pacientes com adenomegalias suspeitas sem biópsia. Crítérios de Inclusão/ Agendamento: a. Bicitopenia após afastar todas as causas clínicas (hipotireoidismo, doenças hepáticas, uso de medicamentos, esplenomegalia com doença hepática); ou b. Citopenias com manifestações clínicas suspeitas de leucemia aguda (fadiga generalizada, fraqueza, palidez, equimose, petéquias, sangramentos, infecções recorrentes); ou - b.1. Citopenias com linfonodomegalia e esplenomegalia não explicada por quadro infeccioso agudo; ou - b.2. Presença de blastos/ promielócitos no sangue periférico; ou - b.3. Paciente com febre + neutropenia ($< 1500 /\mu\text{L}$); ou - b.4. Bicitopenia/pancitopenia com alterações hematológicas graves: • Hemoglobina $< 7 \text{ g/dl}$; e/ou • Neutrófilos $< 500 \text{ cels}/\mu\text{L}$; e/ou • Plaquetas $< 50 \text{ mil cels}/\text{mm}^3$. c. Trombocitose: - c.1. Isolada $> 600.000/\text{mm}^3$ em 3 exames c/ intervalo $< 1\text{m}$; ou - c.2. Acompanhada de leucocitose e aumento do hematócrito. - c.3. Associada a sintomas vasomotores, sangramento ou trombose (após avaliação em serviço de urgência / emergência); ou - c.4. Associada a leucocitose ou policitemia; Excluir: trombocitose persistente após exclusão de causas secundárias (quadro infeccioso atual, anemia ferropriva, esplenectomia /asplenia, trauma/cirurgia recente). d. Leucocitose com desvio à esquerda em ausência de infecção: - d.1. Leucocitose + manifestações clínicas suspeitas de leucemia aguda (fadiga generalizada, fraqueza, palidez, equimose, petéquias, sangramentos, infecções recorrentes); ou - d.2. Presença de blastos e promielócitos no sangue periférico. OBSERVAÇÃO: PACIENTES COM SUSPEITA DE LEUCEMIA AGUDA NÃO SÃO REGULADOS AMBULATORIALMENTE. NECESSÁRIO ESTAR INTERNADO E INSERIDO NO SISTEMA SER PARA TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR.
--	---



4.3.16. Consulta de primeira vez em Oncologia – CARDIOLOGIA

Recurso	Requisitos necessários
AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO	Indicação: • Pacientes Oncológicos apresentando complicações cardíacas relacionadas ao tratamento radioterápico ou quimioterápico. • Pacientes com doença cardíaca necessitando de avaliação pré-quimioterapia. • Pacientes com neoplasia primária do coração. • Inserir no SER o encaminhamento médico com descrição do caso.

4.3.17. Consulta de primeira vez em Oncologia – NEUROLOGIA

Recurso	Requisitos necessários
AVALIAÇÃO EM ONCOLOGIA (NEUROLOGIA)	Critérios de inclusão: • Idade: acima de 18 anos. • Complicações neurológicas de Quimioterapia, Imunoterapia e Radioterapia para Doenças Oncológicas, tais como mielopatias, plexopatias, radiculopatias, miopatias, doenças do neurônio motor, doenças da junção neuromuscular, distúrbios de movimento, demências e prejuízos na cognição, epilepsia e encefalopatias decorrentes dos tratamentos. • Complicações neurológicas de Transplante de medula óssea para Doenças Hemato-Oncológicas, tais como mielopatias, plexopatias, radiculopatias, miopatias, doenças do neurônio motor, doenças da junção neuromuscular, distúrbios de movimento, demências e prejuízos da cognição, epilepsia e encefalopatias decorrentes do tratamento. • Suspeita de Encefalite Paraneoplásica, na presença de neoplasia já identificada. Critério de exclusão: • Tratamento Primário de Doenças Oncológicas, Hemato-Oncológicas, Neoplasias do Sistema Nervoso Central ou Periférico. O ambulatório atende apenas complicações do tratamento destas doenças e não as doenças propriamente ditas. • Encaminhamentos para Neuro-oncologia Cirúrgica. Os atendimentos do ambulatório são apenas clínicos por neurologista. • Encaminhamento para Cuidados Paliativos. Não é o foco de atendimento deste ambulatório e já existem serviços na rede com este perfil. • Encaminhamento para tratamento de Doenças Infecciosas, Dores, Cefaleias, Transtornos emocionais ou psiquiátricos, mesmo que decorrente de tratamentos oncológicos. Não são foco deste ambulatório e já existem serviços na rede com este perfil. • Pacientes graves e instáveis, por se tratar de atendimento ambulatorial. • Indivíduos com menos de 18 anos.



4.3.18. Consulta de primeira vez em Oncologia - PEDIATRIA

Recurso	Requisitos necessários
TRIAGEM EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA	• Inserir no SER o encaminhamento médico com descrição detalhada do caso suspeito de câncer infantil.

4.3.19. Consulta de primeira vez em Oncologia – MEDICINA NUCLEAR

Recurso	Requisitos necessários
PLANEJAMENTO EM RADIOTERAPIA	• Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, indicando o sítio a ser irradiado e apresentando o exame histopatológico. Também, informar o peso do paciente.
PLANEJAMENTO EM RADIOTERAPIA INFANTIL	• Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, indicando o sítio a ser irradiado e apresentando o exame histopatológico.
PLANEJAMENTO EM BRAQUITERAPIA	• Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, indicando o sítio a ser irradiado e apresentando o exame histopatológico. Pacientes não-histerectomizadas deverão anexar risco cirúrgico.
PLANEJAMENTO EM GAMMA KNIFE	• Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, indicando o procedimento e apresentando exame de imagem há menos de 06 meses.
PLANEJAMENTO EM IODOTERAPIA	• Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, indicando o procedimento.



4.4. ORTOPEDIA

- Consultas de primeira vez em Ortopedia.
- Pacientes com diagnóstico de TUMOR ÓSSEO deverão ser encaminhados à fila de Ambulatório de 1ª vez – Tumores do Tecido Ósseo-Conectivo.
- Pacientes com suspeita de metástase óssea deverão ser inseridos de acordo com o sítio primário.
- Pacientes com lesões intrasubstanciais /meniscais degenerativas, tendinites/ Sinovites e Condropatias patelares deverão ser tratadas nos ambulatórios locais.
- **Crítérios de Exclusão: Vigência de infecção.**
- **Todos os encaminhamentos médicos deverão ser encaminhados por Ortopedista.**

4.4.1. Ortopedia – Joelho

Local/tipo de lesão	Requisitos necessários
LESÕES LIGAMENTARES/ MENISCO EM PACIENTES COM MENOS DE 50 ANOS	• Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, indicando o procedimento e apresentando laudo do exame de ressonância magnética.
LESÕES LIGAMENTARES/ MENISCO EM PACIENTES A PARTIR DE 50 ANOS	• Geralmente, para pacientes a partir de 50 anos não se aplica solicitação do procedimento, portanto deve-se discutir com o Ortopedista o tratamento conservador. • Caso o procedimento cirúrgico seja indicado após avaliação pelo ortopedista, para pacientes a partir de 50 anos é obrigatório, além do laudo do exame de RNM, inserir a imagem do exame de RX com carga dos joelhos.
ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO	• Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, indicando o procedimento e inserir a imagem do exame de RX com carga dos joelhos.
OSTEOTOMIA/ DEFORMIDADES ANGULARES	• Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, indicando o procedimento e apresentando laudo de RNM, RX com carga dos joelhos e, se possível, RX panorâmico dos membros inferiores.
INSTABILIDADE FEMOROPATELAR	• Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, indicando o procedimento e apresentando laudo de TC com estudo TA-GT preferencialmente e/ou Laudo de RNM.
JOELHO (INFANTIL – ATÉ 15 ANOS)	• Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, indicando o procedimento e apresentando imagem de RX Joelho em AP e perfil para todos os casos. • Também apresentar RX panorâmico de membros inferiores para os casos de deformidades angulares. • Para lesões menisco-ligamentares, inserir, além do RX joelho em AP e perfil, o laudo da RNM.



4.4.2. Ortopedia – Mão

Local/tipo de lesão	Requisitos necessários
SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO	Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, indicando o procedimento e apresentando exame de USG ou eletroneuromiografia, com laudo, se possível ou um exame clínico detalhado.
CISTO SINOVIAL E DEDO EM GATILHO	Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, indicando o procedimento e apresentando exame, com laudo, de USG ou RNM, se possível.
TENDINOPATIAS	Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, indicando o procedimento e apresentando exame de RNM com laudo, se possível.
FRATURAS DE ESCAFOIDE NÃO CONSOLIDADA	Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, indicando o procedimento e apresentando o laudo de RNM ou TC.
NECROSE DE OSSOS DO PUNHO, INSTABILIDADES CÁRPICAS	Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, indicando o procedimento e apresentando exame laudo de RNM com laudo.
FRATURAS NÃO CONSOLIDADAS, VICIOSAS, PSEUDOARTROSE, ARTROSES DO PUNHO	Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, indicando o procedimento e apresentando exame, com laudo, de RX de punho AP e Perfil ou TC.
MÃO (INFANTIL)	Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, indicando o procedimento e apresentando exame de RX de mão AP e oblíqua.

4.4.3. Ortopedia - Coluna

- Todos os encaminhamentos médicos deverão ser encaminhados por Neurocirurgião ou Ortopedista.**

Local/tipo de lesão	Requisitos Necessários
HÉRNIAS DE DISCO	- Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, apresentando laudo de RNM (Preferência) ou TC da lesão. - Inclui: - Hérnia com compressão medular; - Hérnia com compressão radicular; - Hérnia extrusa; - Abaulamentos discais onde o exame de eletroneuromiografia demonstre comprometimento radicular.
ESCOLIOSE	- Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, indicando se há patologia primária. - Apresentar laudo e imagem de RX Panorâmico de Coluna em AP e Perfil, com medida do ângulo de Cobb > 30º.



TUMOR	Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, com hipótese diagnóstica e apresentando laudo de RNM (Preferência) ou TC da lesão.
ESPONDILOARTROSE	Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, apresentando imagem de RX e/ou laudo de TC e/ou laudo da RNM.
ESPONDILÓLISE	Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, apresentando laudo de TC e/ou laudo da RNM.
ESPONDILOLISTESE	Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, apresentando imagem de RX da coluna e/ou laudo de TC e/ou laudo de RNM.
FRATURAS	- Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, apresentando imagem de RX e/ou imagem e laudo de TC e/ou imagem e laudo da RNM da fratura. - Inclui: - Fraturas cervicais (todas); - Fraturas acompanhadas de déficit neurológico; - Fraturas toro-co-lom-bares com compressão > 50% do corpo vertebral; - Fraturas com retropulsão do muro posterior com compressão do canal medular.
PATOLOGIA CIRÚRGICA DACOLUNA VERTEBRAL (ADULTO E INFANTIL)	Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, apresentando imagem e laudo de TC e/ou imagem e laudo de RNM da fratura.

4.4.4. Consulta de primeira vez em Ortopedia - Quadril Adulto

Local/tipo de lesão	Requisitos Necessários
COXARTROSE	Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, apresentando exame de RX da Bacia + perfil do lado acometido.
OSTEONECROSE	Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, apresentando exame de RX da Bacia + perfil do lado acometido + RNM (laudo e imagem).
IMPACTO FEMORO-ACETABULAR	Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, apresentando o laudo do exame de RNM do lado acometido.
REVISÃO DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL	Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, apresentando exame de RX da Bacia + perfil do lado acometido.



4.4.5. Consulta de primeira vez em Ortopedia - Ombro/Cotovelo

Local/tipo de lesão	Requisitos Necessários
LESÃO LIGAMENTARES OU DO MANGUITO ROTADOR	Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, apresentando imagem e laudo de RNM do ombro.
INSTABILIDADE DO OMBRO	Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada o exame físico, apresentando imagem e laudo de RNM do ombro.
LUXAÇÃO ACRÔMIO-CLAVICULAR	Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada o exame físico, apresentando imagem e laudo de RX do ombro.
FRATURA	Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, apresentando imagem de RX evidenciando fratura(s).
ARTROSE	Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, apresentando imagem do Rx do ombro.

4.4.6. Consulta de primeira vez em Ortopedia - Pediatria (Até 15 anos)

Local/tipo de lesão	Requisitos necessários
ACOMETIMENTO ORTOPÉDICO COM INDICAÇÃO CIRÚRGICA	Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, apresentando imagem do Rx da lesão.

4.4.7. Outros Ambulatórios Ortopédicos

Local/tipo de lesão	Requisitos Necessários
PÉ / TORNOZELO	Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, apresentando imagem do Rx da lesão.
TRAUMAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE (FRATURAS OCORRIDAS EM ATÉ 21 DIAS)	Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, apresentando imagem do Rx PA e Perfil.



SEQUELAS PÓS-TRAUMÁTICAS (FRATURAS CONSOLIDADAS DE FORMA VICIOSA)	• Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, apresentando imagem do Rx PA e Perfil.
RECONSTRUÇÃO E ALONGAMENTO ÓSSEO (FIXADOR EXTERNO)	• Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, apresentando imagem do Rx PA e Perfil.

ATENÇÃO:

- **Após inserir a solicitação, é necessário que a unidade solicitante acompanhe o pedido feito, respondendo corretamente as solicitações da Central (pendências e *follow up*) e, principalmente, comunicando ao paciente de seu agendamento.**
- Esta Central regula apenas o acesso dos pacientes à unidade de saúde. Uma vez atendido, a programação cirúrgica e a técnica a ser utilizada é de inteira responsabilidade da unidade executante.
- Não há como interferir na fila interna das unidades bem como, no tempo de espera para a realização do procedimento.

Orientações gerais:

- Filas adultas: maiores de 16 anos.
- Menores de 16 anos deverão ser inseridos nas filas infantis.
- Em casos de fraturas, todas as solicitações deverão ter o exame de Radiografia da fratura com a data do evento.
- As solicitações devem ter CIDs específicos às suas patologias descritas. Casos com CIDs inespecíficos ou que não estejam de acordo serão pendenciados/cancelados para esclarecimentos/edição.
- Pacientes com quadros de infecção aguda serão pendenciados/cancelados, sendo necessário informar que dentre os critérios de exclusão encontram-se os pacientes com infecção ativa. Importante questionar em qual hospital foi prestado o atendimento inicial (primeira cirurgia) e se foi tentado contato com este para reavaliação e reabordagem. Igualmente, é necessário perguntar se a infecção em questão já se encontra em remissão viabilizando cirurgia definitiva.



4.5. NEUROCIRURGIA

- **Solicitação de consulta em Neurocirurgia**

Recurso	Requisitos necessários
NEUROCIRURGIA - ADULTO E INFANTIL (EXCETO COLUNA)	• Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada a História clínica, o uso de medicamentos regulares (quais?) e tempo da lesão. • Inserir Exames de Imagem (TC ou RNM).
EPILEPSIA REFRACTÁRIA OU FÁRMACO RESISTENTE (ADULTO E INFANTIL)	• Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada o tipo e frequência das crises, as medicações utilizadas, o que comprova a refratariedade e outros tratamentos já tentados (inclusive cirurgias ou tratamentos alternativos), presença de doença psiquiátrica associada e desenvolvimento cognitivo. • Inserir EEG de rotina e RNM de encéfalo (se possível).
PLEXO BRAQUIAL/NERVOS PERIFÉRICOS	• Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada a solicitação médica informando tratamento realizado (clínico e cirúrgico), uso de medicações regulares (quais) e tempo de lesão. • Inserir Exames de Imagem em caso de trauma e eletroneuromiografia (se houver).
NEUROVASCULAR	• Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada o tratamento a ser realizado (clínico e cirúrgico), o uso de medicações regulares (quais) e tempo de lesão. • Inserir Exames de Imagem (TC ou RNM).
PARKINSON/ MOVIMENTOS INVOLUNTÁRIOS	• Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada a necessidade do tratamento cirúrgico a ser realizado, uso de medicações regulares, que comprovem a refratariedade (quais) e tempo de evolução.



4.6. OBSTETRÍCIA – PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO ESTRATÉGICO

4.6.1. Solicitação de Consulta de primeira vez em Pré-Natal em Hospital Terciário.

Recurso	Requisitos necessários
PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO ESTRATÉGICO	Critérios de inclusão - Gestantes que apresentarem: • Cardiopatias • Colagenoses • Doenças Hematológicas • Hemopatias • Nefropatias • Neuropatias • Patologias malignas • Tireoideopatias • Pneumopatias • Gestantes Transplantadas • Patologias uterinas • Incompetência Istmo cervical • Gemelar (sem comorbidades até 28 semanas): somente gestação gemelar mono/monoamniótico ou com corionicidade desconhecida até 16 semanas • Alo imunização materna, sem comorbidades em qualquer idade gestacional (resultado de COOMBS indireto +) • Peso maior que 140Kg (incluir peso e altura na solicitação) • H.P.P. de natimorto, neomorto, prematuridade, malformação fetal • H.P.P. de trombose venosa profunda • H. P. Familiar de cromossomopatias Inserir no SER de forma clara e detalhada: • Encaminhamento médico com a história clínica, relatando o quadro atual, medicações em uso, exames ou relatórios comprovando as patologias acima • Laudo de USG e data provável de parto • Laudo dos exames REALIZADOS com data recente • Para casos de gemelaridade: Laudo de USG c/ gestação gemelar monocoriônica, mono amniótica ou Di-amniótica Critérios de exclusão: • Gestação acima de 36 semanas • Emergências Obstétricas • Bolsa rota



ACONSELHAMENTO EM MALFORMAÇÃO FETAL	Critérios de inclusão - Gestantes que apresentarem aos exames de USG as seguintes patologias: • Mielomeningocele • Onfalocele • Encefalocele • Gastrosquise • Rim policístico bilateral • Dilatação pielocalicial (> 6,5mm) • Hérnia diafragmática • Hidrocefalia • Fetos com múltiplas malformações • Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada o caso. Critérios de exclusão: • Gestação acima de 31 semanas e 6 dias • Malformações cardíacas
---	---

4.7. MICROCIRURGIAS

- **Solicitação de consulta em Microcirurgias**

Recurso	Requisitos necessários
MICROCIRURGIA RECONSTRUTORA (INFANTIL)	• Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada o caso. • Inserir exames realizados pertinentes ao diagnóstico. • Critérios de inclusão: Lesão de plexo braquial, Reconstrução com retalhos musculares ou microcirúrgicos.
MICROCIRURGIA RECONSTRUTORA (ADULTO)	• Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada o caso. • Inserir exames realizados pertinentes ao diagnóstico. • Critérios de inclusão: Lesão de plexo braquial, reconstrução com retalhos musculares ou microcirúrgicos.



4.8. HEMATOLOGIA

4.8.1. Consulta de primeira vez em Hematologia Adulto

Critérios de Exclusão:

- Pacientes em tratamento em outros serviços de Hematologia.
- Anemia hipocrômica **sem** investigação clínica de perda de sangue (qualquer sítio), ingestão inadequado e **sem** dosagem de ferro sérico, transferrina e ferritina sérica.
- Eritrocitose secundária a DPOC.
- TROMBOFILIA

Necessita informar:

- Relato sucinto do quadro clínico, tempo de evolução e tratamento realizados.
- Medicamentos de uso regular (especificar).
- Relato de investigação completa: Se possui história familiar de hematopatia; Se realizou algum tratamento.
- Descartar Virose e intoxicações medicamentosas.
- Descartar o uso de medicamentos que interfiram na coagulação.

• HEMATOLOGIA ADULTO

Alterações hematológicas	Requisitos Necessários
ANEMIA	Inserir no SER: • Encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada o caso. • 02 hemogramas (intervalo > ou = 15 dias) • Eletroforese de proteínas, ferro sérico, ferritina, saturação da transferrina, vitamina B12, ácido fólico • Sorologias para hepatite viral (HBV/ HCV), HIV • Provas de função hepática e Renal/ FAN • Eletroforese de Hb (em suspeita de hemoglobinopatias) Critérios de Inclusão/ Agendamento: • Hemoglobina sérica < 9 g/dl, de padrão macrocítico. • Anemia e icterícia com aumento de bilirrubina indireta. • Anemia normocítica e normocrômica EXCLUÍDAS doenças crônicas como Insuficiência Renal, diabetes mellitus, colagenoses e hepatopatias.
DISTÚRBIOS DOS LEUCÓCITOS (LEUCOPENIA)	Inserir no SER: • Encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada o caso. • 02 hemogramas recentes (intervalo mínimo de 1 mês) Critério de Inclusão/ Agendamento: • Leucometria global < ou = 3000/mm³. • Neutrófilos < ou = 1200/mm³ • Atipias linfocitárias na ausência de quadro viral agudo • Esplenomegalia no adulto, DEPOIS DE AFASTADA doença hepática de qualquer etiologia.



Distúrbios Hemorrágicos	Inserir no SER: • Encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada o caso. • Coagulograma e Plaquetas (2 exames diferentes). Critério de Inclusão/ Agendamento: • Síndromes hemorrágicas: hematomas, equimoses, epistaxes, metrorragia (quando isolada deve ser avaliada ginecológica) com plaquetas < 75.000 e/ou TAP ou PTT alterados. • Alterações no coagulograma em exames subsequentes.
---------------------------------------	---

4.8.2. Consulta de primeira vez em Hematologia Pediátrica

Critérios de Exclusão:

- Menores de 1 ano de idade, salvo com suspeitas de doenças hemorrágicas hereditárias ou hemoglobinopatias.
- Anemia hipocrômica **sem** investigação clínica de perda de sangue (qualquer sítio), ingesta inadequado e **sem** dosagem de ferro sérico, transferrina e ferritina sérica.

Necessita informar:

- Relato sucinto do quadro clínico, tempo de evolução e tratamento realizados.
- Medicamentos de uso regular (especificar).
- Relato de investigação completa: Se possui história familiar de hematopatia; Se realizou algum tratamento.
- Descartar Viroses e intoxicações medicamentosas.
- Descartar o uso de medicamentos que interfiram na coagulação.



• HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA

Alterações hematológicas	Requisitos necessários
ANEMIA	Inserir no SER: • Encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada o caso. • 02 hemogramas (intervalo > ou = 15 dias). • Eletroforese de proteínas, ferro sérico, ferritina, saturação da transferrina, vitamina B12, ácido fólico. • Eletroforese de Hb (em suspeita de hemoglobinopatias). • Teste do Pezinho com alterações para hemoglobinopatias, Deficiência de G6PD. Critérios de Inclusão/ Agendamento: • Hemoglobina sérica < 9 g/dl, de padrão macrocítico. • Anemia e icterícia com aumento de bilirrubina indireta. • Anemia normocítica e normocrômica EXCLUÍDAS doenças crônicas como Insuficiência Renal, diabetes mellitus, collagenoses e hepatopatias.
DISTÚRBIOS DOS LEUCÓCITOS (LEUCOPENIA)	Inserir no SER: • Encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada o caso. • 02 hemogramas recentes (intervalo mínimo de 1 mês). Critério de Inclusão/ Agendamento: • Leucometria global < ou = 3000/mm³. • Neutrófilos < ou = 1200/mm³. • Atipias linfocitárias na ausência de quadro viral agudo. • Esplenomegalia.
DISTÚRBIOS HEMORRÁGICOS	Inserir no SER: • Encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada o caso. • Coagulograma e Plaquetas (2 exames diferentes). Critério de Inclusão/ Agendamento: • Síndromes hemorrágicas: hematomas, equimoses, epistaxes, metrorragia (quando isolada deve ser avaliada ginecológica) com plaquetas < 75.000 e/ou TAP ou PTT alterados. • Alterações no coagulograma em exames subsequentes.

4.9. CIRURGIA CRÂNIO-MAXILO-FACIAL

• Solicitação de consulta de Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial

Local da lesão	Requisitos Necessários
CRÂNIO-MAXILO-FACIAL (ADULTO)	• Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, apresentando imagem do Rx PA e Perfil ; TC (se possível).
CRÂNIO-MAXILO-FACIAL (INFANTIL)	• Inserir no SER o encaminhamento médico descrevendo de forma clara e detalhada, apresentando imagem do Rx PA e Perfil; TC (se possível).



4.10. CIRURGIA PLÁSTICA

- **Solicitação de consulta de Cirurgia Plástica**

Recurso	Requisitos necessários
CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA DE MAMA (PÓS-MASTECTOMIA ONCOLÓGICA)	• Inserir no SER de forma clara e detalhada o encaminhamento médico com indicação do local e data da realização da mastectomia por doença oncológica e liberação para a realização do procedimento de cirurgia reparadora.

4.11. GENÉTICA MÉDICA

- **Solicitação de consulta de Genética Médica**

Recurso	Requisitos necessários
GENÉTICA MÉDICA PEDIÁTRICA	Critérios de inclusão: • Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clínica do caso. • Pacientes na faixa etária de 0 a 19 anos incompletos. • Pacientes portadores das seguintes condições: ○ Dismorfias, Anomalia Congênita e/ou Malformação Congênita. ○ Genitália ambígua. ○ Fraturas Patológicas. ○ Osteogênese imperfeita. ○ Síndromes com Malformações Congênitas que acometem Múltiplos Sistemas. ○ Doenças do desenvolvimento para uma investigação de uma síndrome genética. ○ Deficiência Intelectual e/ou Autismo SINDRÔMICO. ○ Síndromes com malformações congênitas associadas ao Nanismo. ○ Erros Inatos do Metabolismo (Aminoácido; Carboidratos; Glicosaminoglicano). ○ Suspeita de bebês com síndrome de Down. ○ Anomalia Cromossômica Constitucional. ○ Doenças Raras. • Observar critérios de inclusão e exclusão do prestador.
GENÉTICA MÉDICA ADULTO	Critérios de inclusão: • Inserir no SER o encaminhamento médico com a descrição clínica do caso. • Pacientes com necessidade de Aconselhamento Genético, com história pessoal ou familiar de condição de causa genética e/ou malformação congênita, excluindo câncer familiar. • Pacientes com Aborto de Repetição: História de 03 abortos espontâneos ou mais de primeiro trimestre previamente investigados das causas infecciosas, materna, imunológicas, metabólicas e placentária. • Observar critérios de inclusão e exclusão do prestador. Critérios de exclusão: • Síndrome de Down já diagnosticado (acompanhamento Atenção Primária). • Síndrome Genética já diagnosticada (acompanhamento Atenção Primária). • Suspeita da síndrome do X-frágil. • Autismo isolado não-sindrômico (Autismo Isolado; Autismo Asperger).

	• Doença de Huntington. • Síndromes de Ataxia Hereditárias. • Ataxias Hereditárias familiar de instalação no Adulto.
--	--

4.12. OUTRAS ESPECIALIDADES

• Solicitação de consulta em Outras Especialidades

Recurso	Requisitos necessários
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INFECÇÃO CONGÊNITA ZIKA/ STORCH/CHIKUNGUNHA	• Inserir no SER de forma clara e detalhada o encaminhamento médico de casos suspeitos de infecção congênita em crianças.
HORMONIZAÇÃO SAÚDE - TRANS	Inserir no SER de forma clara e detalhada: • Encaminhamento médico. • Idade a partir de 16 anos.
CENTRO DE REFERÊNCIA MULTIDISCIPLINAR PÓS-COVID 19	Inserir no SER de forma clara e detalhada: • Encaminhamento médico. • Comprovação de infecção prévia por COVID-19. • Descrição de internação e tipo de leito. • Critérios de inclusão: Pacientes com agravamento de comorbidades ou sequelas após a infecção por COVID-19.

4.13. TRANSPLANTE

• Solicitação de consulta para Transplante

Recurso	Requisitos necessários
CARDÍACO	Critério de inclusão: Idade inferior aos 65 anos. Indicações: • Insuficiência Cardíaca Classe III ou IV (NYHA). • Insuficiência Cardíaca Classe II, III ou IV + Terapia de Ressincronização Cardíaca. • Cardiomiopatia Hipertrófica Anexar: • Encaminhamento por cardiologista com descrição do caso. • Ecocardiograma (< 6m); Holter 24 horas (se necessário).
RENAL (INFANTIL)	Anexar (ou descrever de forma clara e detalhada): • Encaminhamento médico com descrição do caso.
FÍGADO (INFANTIL)	Anexar (ou descrever de forma clara e detalhada): • Encaminhamento médico com descrição do caso.



RENAL	Anexar (ou descrever de forma clara e detalhada): • Encaminhamento médico com descrição do caso. • Dias em que realiza o tratamento dialítico. • Informar o tipo de acesso vascular. • Exames laboratoriais (sorologias, Hematócrito e Hemoglobina e ureia e Creatinina). • Informar, caso seja vontade do paciente, o Centro Transplantador de preferência.
PULMONAR	Anexar (ou descrever de forma clara e detalhada): • Encaminhamento médico com descrição do caso. Critérios de Exclusão: Pacientes agudamente doentes ou clinicamente instáveis.

4.14. CINTILOGRAFIAS

Recurso	Requisitos necessários
CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO EM REPOUSO E ESTRESSE AMBULATORIAL	Inserir no SER: • Solicitação médica em formulário de Alto Custo, com indicação da patologia cardíológica suspeita ou comprovada. • ECG, Ecocardiograma, Teste ergométrico Obs: Especificar se o exame de estresse será realizado em esteira ou farmacológico.
CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO (PACIENTES INTERNADOS)	Inserir no SER: • Solicitação médica em formulário de Alto Custo, com indicação da patologia cardíológica suspeita ou comprovada. Modo ventilatório • ECG, Ecocardiograma, Teste ergométrico Obs.: Destina-se a pacientes internados
CINTILOGRAFIA RENAL ESTÁTICA E/OU DINÂMICA - DMSA (AMBULATORIAL)	Inserir no SER: • Solicitação médica em formulário de Alto Custo, com indicação da patologia suspeita.
CINTILOGRAFIA DE OSSOS COM OU SEM FLUXO SANGUÍNEO - CORPO INTEIRO (AMBULATORIAL)	Inserir no SER: • Solicitação médica em formulário de Alto Custo, com indicação da patologia suspeita.
CINTILOGRAFIA DE PULMÃO POR VENTILAÇÃO E/OU PERFUSÃO (AMBULATORIAL)	Inserir no SER: • Solicitação médica em formulário de Alto Custo, com indicação da patologia suspeita.
CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE COM OU SEM CAPTAÇÃO (AMBULATORIAL)	Inserir no SER: • Solicitação médica em formulário de Alto Custo, com indicação da patologia suspeita.
CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO PESQUISA DE NEOPLASIAS (AMBULATORIAL)	Inserir no SER: • Solicitação médica em formulário de Alto Custo, com indicação da patologia suspeita.



LINFCINTILOGRAFIA (AMBULATORIAL)	Inserir no SER: • Solicitação médica em formulário de Alto Custo, com indicação da patologia suspeita.
CINTILOGRAFIA DE FÍGADO E VIAS BILIARES (AMBULATORIAL)	Inserir no SER: • Solicitação médica em formulário de Alto Custo, com indicação da patologia suspeita.
CINTILOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES / EXTREMIDADES / ÓSSEA (AMBULATORIAL)	Inserir no SER: • Solicitação médica em formulário de Alto Custo, com indicação da patologia suspeita.
CINTILOGRAFIA DE CAMPOS PULMONARES E ESVAZIAMENTO GÁSTRICO (AMBULATORIAL)	Inserir no SER: • Solicitação médica em formulário de Alto Custo, com indicação da patologia suspeita.
CINTILOGRAFIA DE CÂMARAS CARDÍACAS	Inserir no SER: • Solicitação médica em formulário de Alto Custo, com indicação da patologia suspeita.

4.15. TESTE DO SUOR – DOSAGEM DE CLORETO NO SUOR

4.15.1. PREPARO PARA O PROCEDIMENTO

a. SOMENTE após o segundo mês de vida.
b. NÃO apresentar com febre (se temperatura acima de 37,5°C e deverá ser reagendado).
c. É NECESSÁRIO SUSPENDER corticoide 30 dias antes do exame. (<u>consulte seu médico antes de suspender o medicamento</u>).
d. Beber líquidos de hora em hora, usando recipiente de uso habitual, (exceto refrigerantes) 03 dias ANTES DO EXAME.
e. NÃO USAR nenhum tipo de creme ou pomada nos braços e tronco do paciente, dois (2) dias antes do exame.
f. Levar um agasalho, que será usado na hora do exame.
g. Observar demais orientações do prestador.

4.16. ELASTOGRAFIA

4.16.1. PREPARO PARA O PROCEDIMENTO

a. Maiores de 18 anos.
b. Jejum absoluto de 6 horas.
c. Pacientes portadores de hepatites crônicas por vírus (B,C), álcool, gordura no fígado, doença autoimune, uso crônico de medicamentos (artrite reumatoide, psoríase, CA de Mama). Nas doenças agudas não há indicação.
d. Contraindicação: Gravidez, Enzimas do fígado muito altas(>400).
e. Suspende medicamentos para Glicose no dia do exame.
f. Observar demais orientações do prestador.

4.17. OUTROS EXAMES

Local/tipo de lesão	Requisitos necessários
TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT)	Inserir no SER, descrevendo de forma clara e detalhada: • Encaminhamento médico com descrição do caso. • Formulário de Alto Custo. • Estadiamento clínico do câncer de pulmão de células não pequenas (carcinoma epidermoide, adenocarcinoma e carcinoma de células grandes), potencialmente ressecável. • Detecção de metástases exclusivamente hepáticas e potencialmente ressecáveis de câncer colorretal. • Estadiamento e avaliação da resposta ao tratamento de linfomas de Hodgkin e não-Hodgkin.
ANGIOTOMOGRAFIA	Inserir no SER, descrevendo de forma clara e detalhada: • Encaminhamento médico com descrição do caso. • Formulário de Alto Custo.
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO (INTERNADOS)	Inserir no SER, descrevendo de forma clara e detalhada: • Encaminhamento médico com descrição do caso. • Formulário de Alto Custo. • Modo ventilatório • Atualização diária de evolução clínica, descrita no sistema SER. • Destina-se apenas para pacientes internados, acima de 5 anos de idade que não necessitam de sedação. Tipos de exames: • RNM de Crânio, Face, ATM, Mastoide, Órbitas, Coluna Cervical, Torácica e Lombar, Pescoço. • Angiorressonância de Crânio e/ou Pescoço.



RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO (INTERNADOS)	Inserir no SER, descrevendo de forma clara e detalhada: • Encaminhamento médico com descrição do caso. • Formulário de Alto Custo. • Modo ventilatório. • Atualização diária de evolução clínica, descrita no sistema SER. • Destina-se apenas para pacientes internados. Tipos de exames: • RNM de Crânio, Face, ATM, Mastoide, Órbitas, Coluna Cervical, Torácica e Lombar, Pescoço. • Angiorressonância de Crânio e/ou Pescoço.
ELETROENCEFALOGRAMA (ADULTO)	Inserir no SER, descrevendo de forma clara e detalhada: • Encaminhamento médico com descrição do caso. • Critérios de exclusão: Pacientes com necessidade de sedação.
ELETROENCEFALOGRAMA (INFANTIL)	Inserir no SER, descrevendo de forma clara e detalhada: • Encaminhamento médico com descrição do caso. • Critérios de exclusão: Pacientes com necessidade de sedação.
VÍDEO EEG (ADULTO)	Inserir no SER, descrevendo de forma clara e detalhada: • Encaminhamento médico com descrição do caso. • Critérios de exclusão: Pacientes com necessidade de sedação.
VÍDEO EEG (INFANTIL)	Inserir no SER, descrevendo de forma clara e detalhada: • Encaminhamento médico com descrição do caso. • Critérios de exclusão: Pacientes com necessidade de sedação.

4.18. EXAMES QUE REQUEREM PREPARO PRÉVIO

4.18.1. Preparo prévio para Angioplastia

a.	Jejum absoluto de 4 horas antes do exame: Não tomar café da manhã.
b.	Pode tomar medicamentos com água.
c.	Trazer receita médica e exames realizados: Eletrocardiograma, RX, Teste Ergométrico, ECO, Cintilografia Miocárdica, Holter, Cateterismo (laudo e filme).
d.	Apresentar documentos de identificação do paciente: identidade, CPF, Comprovante de residência, cartão do SUS, pedido do exame, exame laboratorial recente (hemograma e bioquímica), prescrição médica atual.
e.	Documentos de identificação do acompanhante: identidade.
f.	Iniciar 3 (três) dias antes, no mínimo, do agendamento as seguintes medicações: • AAS 100mg (Aspirina Prevent, Somalgin, etc.) – 2 comprimidos após o almoço. • Clopidogrel 75mg (Plagrel, Plavix, Iscover, Lopidogrel) – 1 (Um) comprimido, Via Oral, 1 (Uma) vez ao dia.
g.	DIABÉTICOS – NÃO DEVERÃO TOMAR: • Insulina – Interromper o uso 1 (Um) dia antes do exame. • Hipoglicemiantes orais – Interromper o uso 3 (Três) dias antes do exame (Amaryl, Daonil, Diabinese, Diamicron, Glifage, Metformina, etc.).
h.	Paciente uso de MAREVAN: • Solicitar orientação médica quanto a necessidade de suspender o medicamento 3 (três) dias antes da realização do exame.



i. Paciente ALÉRGICO A IODO: • Tomar Meticorten 20mg – 1 cápsula, 2 vezes ao dia por via oral, durante 3 (Três) anteriores ao dia do exame. • Polaramine 2mg – 1 cápsula, 2 vezes ao dia por via oral, durante 3 (Três) anteriores ao dia do exame. • Ranitidina 150mg – 1 cápsula a noite por via oral, durante 3 (três) anteriores ao dia do exame.
j. Manter as medicações prescritas pelo médico do paciente, exceto as constantes nos subitens “g” e “h”.

Observações:

- Informar ao paciente todas as orientações descritas acima.
- O não cumprimento de qualquer um dos itens pode acarretar cancelamento do exame.

4.18.2. Preparo prévio para Arteriografia de membros

a. Jejum absoluto de 7 (Sete) horas antes do exame.
b. Documentos de identificação do paciente: identidade, CPF, Comprovante de residência, cartão do SUS, pedido do exame, exame laboratorial recente (hemograma e bioquímica, prescrição médica atual).
c. O exame de bioquímica deve conter, principalmente, ureia, creatinina e coagulograma.
d. Os pacientes devem vir higienizados, sem adornos e próteses.
e. Apresentar relatório médico, da unidade de origem, com caso detalhado.
f. Obrigatório a presença do acompanhante com documento de identificação.
g. Suspende medicações, conforme orientação abaixo: • Metformina – suspender 48h antes do exame. • Sulfonilureias – suspender na manhã do exame. • Diuréticos – suspender na manhã do exame. • Insulina – suspender na manhã do exame. • Clexane – suspender no dia anterior ao exame.
h. Paciente ALÉRGICO A IODO: • Tomar Meticorten 20mg – 1 cápsula, 2 vezes ao dia por via oral, durante 3 (três) anteriores ao dia do exame. • Polaramine 2mg – 1 cápsula, 2 vezes ao dia por via oral, durante 3 (três) anteriores ao dia do exame. • Ranitidina 150mg – 1 cápsula a noite por via oral, durante 3 (três) anteriores ao dia do exame.

Observações:

- Informar ao paciente todas as orientações descritas acima.
- O não cumprimento de qualquer um dos itens pode acarretar cancelamento do exame.



4.18.3. Preparo prévio para Cateterismo Cardíaco

a. Jejum absoluto de 4 horas antes do exame: Não tomar café da manhã.
b. Pode tomar medicamentos com água.
c. Trazer receita médica e exames realizados: Eletrocardiograma, RX, Teste Ergométrico, ECO, Cintilografia Miocárdica, Holter, Cateterismo (laudo e filme).
d. Apresentar documentos de identificação do paciente: identidade, CPF, Comprovante de residência, cartão do SUS, pedido do exame, exame laboratorial recente (hemograma e bioquímica), prescrição médica atual.
e. Documentos de identificação do acompanhante: identidade.
f. Iniciar 3 (três) dias antes, no mínimo, do agendamento as seguintes medicações: • AAS 100mg (Aspirina Prevent, Somalgin, etc.) – 2 comprimidos após o almoço. • Clopidogrel 75mg (Plagrel, Plavix, Iscover, Lopidogrel) – 1 (Um) comprimido, Via Oral, 1 (Uma) vez ao dia.
g. DIABÉTICOS – NÃO DEVERÃO TOMAR: • Insulina – Interromper o uso 1 (Um) dia antes do exame. • Hipoglicemiantes orais – Interromper o uso 3 (Três) dias antes do exame (Amaryl, Daonil, Diabinese, Diamicron, Glifage, Metformina, etc.).
h. Paciente uso de MAREVAN: • Solicitar orientação médica quanto a necessidade de suspender o medicamento 3 (três) dias antes da realização do exame.
i. Paciente ALÉRGICO A IODO: • Tomar Meticorten 20mg – 1 cápsula, 2 vezes ao dia por via oral, durante 3 (Três) anteriores ao dia do exame. • Polaramine 2mg – 1 cápsula, 2 vezes ao dia por via oral, durante 3 (Três) anteriores ao dia do exame. • Ranitidina 150mg – 1 cápsula a noite por via oral, durante 3 (três) anteriores ao dia do exame.
j. Manter as medicações prescritas pelo médico do paciente, exceto as constantes nos subitens “g” e “h”.

Observações:

- Informar ao paciente todas as orientações descritas acima.
- O não cumprimento de qualquer um dos itens pode acarretar cancelamento do exame.

4.18.4. Preparo prévio para Teste Cardiopulmonar de Exercício (Ergoespirometria)

a. Documentos de identificação do paciente: identidade, CPF, Comprovante de residência, cartão do SUS, pedido do exame.
b. Trazer o agendamento do SER (espelho) com o número da chave de autorização.
c. Documentos de identificação do acompanhante: carteira de identidade.
d. Chegada do paciente com acompanhante: 30 minutos antes do horário marcado.
e. Homem: trazer aparelho de barbear descartável.
f. Mulher: vestir sutiã ou top por baixo da blusa.
g. Levar bermuda, toalha e tênis (caso não tenha, não precisa comprar).
h. Manter as medicações prescritas pelo médico do paciente.
i. O paciente NÃO deve estar em jejum nem comer demais antes da hora marcada para o exame.
j. O paciente ao chegar na unidade executante deve se dirigir ao NIR.

Observações:

- Informar ao paciente todas as orientações descritas acima.
- O não cumprimento de qualquer um dos itens pode acarretar cancelamento do exame.



4.18.5. Preparo prévio para Eletroencefalograma

a. Documentos de identificação do paciente: identidade, CPF, Comprovante de residência, cartão do SUS, pedido do exame.
b. Trazer o agendamento do SER (espelho) com o número da chave de autorização.
c. O paciente deverá lavar bem os cabelos usando um sabonete neutro (como sabão de coco) mas com tempo suficiente para que estejam secos ao início do procedimento, de preferência na noite anterior.
d. Não utilizar nenhum cosmético no cabelo (laque, gel, condicionador, cremes, óleos, tinturas) não é necessário suspender os medicamentos de uso contínuo, mas eles devem ser informados ao médico.

Observações:

- Informar ao paciente todas as orientações descritas acima.
- O não cumprimento de qualquer um dos itens pode acarretar cancelamento do exame.